2026.8.27–8.29

女性脑科学

身体感知与女性健康的整体地图

连接身体感知、压力与睡眠、周期、消化、盆底和亲密体验，跨三天读懂课程的整体脉络。

阅读方式

先看地图，再读主题；用表格比较，用逻辑图串联。正文编号可跳转到出处索引；无需在大段原文中反复寻找。

本课目录

01 三天课程的整体地图

02 身体感知：输入、体验与功能的区别

03 压力与睡眠：把笼统困扰拆成具体模式

04 月经与内分泌：用时间线读懂变化

05 感觉与动作演示：按目的理解不同方法

06 消化、胸壁与瘢痕：分开感受、外观和功能

07 盆底与排尿：三个问题，一条协调链

08 性健康与身体接纳：以本人体验为中心

09 跨文件案例：看见连续过程与不同结局

10 把课程串成可复习、可讨论的知识体系

资料范围：73份。各篇主题映射与具体文件页码见书末出处索引。

本书用于课程学习与复盘。课堂模型、现场观察、整理补充和外部核对分别表达；原文与旧版逐篇PDF保留在原资料夹。

三天课程的整体地图

课程将女性不同生命阶段的身体变化，与感觉、动作、压力和生活体验联系起来。三天内容虽然按现场问答推进，但整理后可沿“认识身体→理解状态→区分具体功能→观察变化”阅读。神经系统是讲者采用的主要视角，身体、关系和医疗背景仍需共同保留。[8.27-01][8.27-02][8.27-03]

身体发生什么

月经、孕产、哺乳、手术与年龄阶段可能改变身体和日常需求；每个人的经历与恢复速度不同。

本人怎样体验

身体形象、疼痛、疲劳、睡眠、尿意及亲密体验需由本人描述，不用性别概括替代个体信息。

实际影响什么

把体验联系到睡觉、进食、行走、排尿、运动与关系中的具体困难，再选择相应主题。

主题	核心问题	三天资料的连接
身体感知与平衡	我怎样感到身体的位置、状态和动作?	8.27的感觉与演示，连接8.29的头眼、节拍和动作案例。
压力与睡眠	外界要求、个人资源和睡眠表现怎样相互关联?	8.27自主神经导入，8.28睡眠/情绪案例，8.29次日反馈。
月经与内分泌	周期、症状与检查如何放在同一时间线上?	8.28内分泌框架，联系孕产经历与收尾出血问答。
消化、胸壁与术后感受	痛、胀、外观和组织变化怎样区分?	8.27腹部个案，8.28肋间与乳房观察，8.29瘢痕案例。
盆底、储尿与排尿	尿意、漏尿和排空分别发生了什么?	8.28未完成的排尿主题，接8.29演示和系统复盘。
性健康与身体接纳	困扰出在哪个环节，本人有哪些需要与意愿?	8.29阶段框架、疼痛/感觉问答及身体接纳收尾。

生命与生活背景 → **具体感受** → **功能表现** → **复盘与支持**

阶段、经历、支持与需求 | 用本人语言说明 | 睡眠、动作、排尿等 | 分项观察，选择相应路径

把这些内容连起来

整理补充：这张地图表达各主题的阅读关系，不意味着一个脑区或一种手法能统一解释所有女性健康问题。课堂的共同方法是先收集体验，再看功能；每个主题还需要自己的定义、指标和证据。学习可先从最相关的两三个问题入手，再补齐概念。[8.27-01]

复习与应用

先选一个真实学习目标，例如“区分尿急和漏尿”或“看懂睡眠案例”。沿地图找概念、案例和复盘表，避免被现场顺序牵着走。

身体感知：输入、体验与功能的区别

闭眼身体形象、镜像观察、轻触与平衡练习，贯穿了三天课程。理解这些演示，需要同时记录感觉来源、观察条件和本人反馈。身体形象模糊、漂浮或左右不同，属于当时的体验，不是自动对应某种病变的诊断图。[8.27-10][8.27-11][8.27-12]

外部与接触信息

视觉、听觉、触觉等帮助认识环境与身体。镜像和手机影像改变了可获得的信息。

位置与运动信息

本体感觉与前庭相关信息参与姿势和动作；课堂把它们与稳定、身体位置感联系起来。[8.28-09]

内部状态体验

内感知（interoception）关注内部状态的感受。胀感、心跳感和尿意要与实际器官功能分开记录。[8.27-24]

概念或现象	如何理解	记录要点
触觉与本体感觉	皮肤接触信息与身体位置/运动信息各有侧重	力量、接触感和位置感不能互相替代。[8.28-09]
身体意象/身体感受	对身体形状、边界和清晰程度的主观报告	保留本人比喻，不把“香蕉形”“漂浮”变成疾病名称。[8.27-11][8.27-12]
视觉反馈	观看自己的影像或动作，可能改变注意与体验	注明镜像、睁闭眼及姿势条件。[8.27-03][8.27-10]
姿势与支撑	坐姿、仰卧、脚落地与被支持时的体验可不同	先对齐条件，再比较分数。[8.27-10][8.27-11]
痛与不适	是真实的个人体验，不能被“脑参与”否定	与功能、情绪和既往伤病分别记录。[8.28-05][E01]
主动与被动表现	自己做和他人辅助做的动作条件不同	差异提供观察线索，不能单独排除结构问题。[8.29-17]

输入条件 → **本人体验** → **任务表现** → **同条件复测**

视觉、接触、姿势与支持 | 清晰度、舒适度与症状 | 能否完成，如何完成 | 记录变化及不确定性

把这些内容连起来

整理补充：一个人“感觉身体更完整”，并不直接意味着肌力增加、病灶消失或睡眠已改善。这些结果需要各自测量。把“体验—功能—结构”画成三列，能避免用最容易得到的主观反馈替代最想证明的临床结果。

复习与应用

把“感觉好多了”改成具体描述：哪一部位、哪一种感觉、什么姿势下发生变化；再单独记录对应动作是否改变。

压力与睡眠：把笼统困扰拆成具体模式

课程用“挑战与资源”理解压力，也讨论活动与休息的切换。这个视角有助于盘点负荷、休息和支持，但不能把现实伤害或关系问题归咎于本人身体差。睡眠则需要独立记录入睡、夜醒、睡眠机会和白天影响。[8.27-08][8.27-09][8.28-10][8.28-11]

外界要求

学习难度、工作节奏、家庭期待及关系处境。发生过的伤害和持续压力不能被一个身体解释抹去。

可用资源

休息、能力、支持、选择空间和既往经验。课程中的“个人资源”可扩展为环境与社会支持。

当下反应

紧张、疲劳、手汗、身体感受与睡眠分别记，不从一种反应推断全部激素或脑区状态。

表现或主题	值得问清什么	与课堂材料的联系
难入睡	是否有足够睡眠机会，何时上床，多久入睡	与主动玩手机到很晚分开。[8.28-10]
反复醒/睡得浅	夜醒次数、清醒多久、能否再睡、环境与饮品	“一晚都醒着”是主观睡感，不能直接算出睡眠时长。[8.28-10]
学习后疲劳	内容太陌生、难度过高，还是连续信息过量	调整学习段落与复盘节奏，不直接解释为脑供血不足。[8.27-08]
事件引发情绪	针对什么事件，当前感觉与本人意愿是什么	身体舒服与事件影响减轻不是同一个结果。[8.28-06][8.28-07]
声音不适	声音类型、强度、触发症状及是否出现耳痛	有耐受改变，也有负面反馈，不能只记正向结果。[8.28-12][8.28-13]
次日反馈	实际睡眠表现与白天状态，有无其他变化	8.29有人自述昨夜睡得较好，未形成可归因的长期随访。[8.29-01]

明确困难 → **补充背景** → **分别观察** → **追踪变化**

入睡、夜醒或主动延迟 → 作息、饮品、环境与支持 → 睡眠、情绪、身体体验 → 次日与之后，保留其他因素

把这些内容连起来

整理补充：课堂在操作后预测“今晚会睡好”，只是一项待验证预期；只有实际夜间记录才能回答。即使次日有人说睡得好，也不能将多人零散反馈拼成同一个案的完整结果，更不能宣称创伤或抑郁已被现场解决。[8.28-13][8.28-20][8.29-01]

复习与应用

复盘时分开写三句话：“当时身体如何”“对事件的感受如何”“当晚睡眠如何”。若某项没有资料，保留为空。

月经与内分泌：用时间线读懂变化

内分泌部分的核心是分清调节层次与不同通路：下丘脑、垂体与相应靶腺之间存在信号和反馈关系；压力、生殖与甲状腺话题不能画成同一条单向路线。具体问题仍需回到周期、症状、检查和用药背景。[8.28-01][8.28-02][8.28-03]

调节轴分开看

课程讨论下丘脑—垂体—肾上腺与下丘脑—垂体—卵巢两条主线。可以相互影响，但承担不同功能。

周期按本人记录

记录出血首日、间隔、持续天数、量与痛感，比较本人以往模式。28天不是人人必须达到的标准。[E06]

检查带背景读

保留实际报告、单位、参考范围、周期时点和用药信息；不凭一个数值或一句“有月经”下结论。

主题	整合后的理解	需要保留的信息
周期变化	月经是一个时间过程；一次提前或推迟不能说明唯一病因	实际日期、连续趋势、疼痛、经量与生活影响。[8.28-02]
压力与生活	可与周期一同观察，但不能用安全感统一解释所有变化	工作、休息、身体状态及其他同期变化。[8.28-03][8.28-04]
多囊相关话题	经期稀发、多毛等是需要进一步了解的线索	诊断依据和其他可能原因，不以爱吃甜食代替评估。[8.28-02]
甲状腺话题	TSH、T3、T4及抗体各有含义，不能共用一个阈值	具体检验项目、单位、参考范围和既往结果。[8.28-03]
备孕、手术与内膜	结构、激素、症状与周期阶段分开理解	原始超声、手术资料、病史与检查时点。[8.28-03][8.28-04]
持续出血与节育环	收尾问答是独立健康问题，不能统一归为神经感觉	出血模式、器具型号/使用时间及专业评估需求。[8.29-23]

记录日期与症状 → **比较个人模式** → **加入检查背景** → **提出具体问题**

先得到真实时间线 | 看变化而非单一标准 | 时点、单位、用药 | 交给相应评估路径

把这些内容连起来

整理补充：月经记录的价值，是把“最近不正常”变成可以讨论的趋势。一般信息中，NHS列出常见成人周期21–35天，但个人阶段与变化仍需结合理解；日历也不能保证排卵或避孕安全。本笔记不沿用课堂固定受孕日或“血量越多越好”的说法。[8.28-01][8.28-02][E06]

复习与应用

复习图可画成三条并列线：周期日期、身体症状、生活与检查事件。线之间的重合提示值得问的问题，并不自动证明因果。

感觉与动作演示：按目的理解不同方法

三天演示可以按观察目的分组：稳定反应、面部触觉与转头、全身开合配合、头眼配合、镜像及手指节拍。下面整理的是各类演示的意图和反馈维度；动作名称、成人反射判定及部分术语尚有不确定处，不补成独立操作程序。

先看目的

想观察稳定性、触觉反应、动作配合，还是对身体的感受？目的不同，不能共用一个“有效”指标。

再看条件

姿势、视线、支撑、主动/被动、辅助者及节奏，都会改变任务本身。

最后看耐受

能完成多少、是否害怕、疲劳、疼痛或头晕，都属于结果，而非必须熬过的过程。

课堂类别	希望观察什么	应怎样读反馈
前庭相关演示	接受重心变化时的稳定与身体感受	先看基础能否完成；向前或向后倒不能直接诊断病因。[8.27-13][8.27-15]
觅食反射相关	面部触觉反应及转头体验	痒、抽动或脸手差异不是已经验证的成人诊断标准。[8.27-16][8.27-17][8.27-20]
惊吓/Moro相关	头、眼与全身开合的配合	名称具体所指待核；受痛与支持条件影响，保留未完成与加重。[8.27-18][8.27-19][8.27-20]
头眼配合	注视、头部运动与原有活动表现	腰部轻松、坐骨仍不适、眼酸疲劳分别写。[8.29-15][8.29-16]
镜像与分级动作	身体体验、动作信心与尝试能力	多种反馈同时出现，不能单独归因一种技术。[8.29-18][8.29-22]
手指节拍	节律完成、注意与身体感受	约94拍为课堂设置；顺序前后有变化，疲劳/手抖/烦躁也需记录。[8.29-20][8.29-21][8.29-23]

明确观察目标 → **选择可完成条件** → **记录全部反馈** → **回到原问题**

先定义何为变化　支持与挑战匹配　包含无效和新不适　而非只检查动作次数

把这些内容连起来

整理补充：分级的逻辑是“先能舒适完成，再讨论增加要求”。它不等于统一次数、速度或固定器械。儿童与成人的目标及条件不同；下颌、言语和成人反射问题不能仅因名称相近就套用另一门课的动作。[8.27-21][8.27-22][8.27-23] 平衡障碍也可能涉及不同原因，需要个体化评估。[E04]

复习与应用

为一项演示写出四个词：目的、条件、反馈、缺口。若无法写清条件，就把它作为回看现场视频的线索，而不作为照做教程。

消化、胸壁与瘢痕：分开感受、外观和功能

这组主题的共同问题是：本人感觉到的痛、胀、凉、紧，与组织结构或器官功能是什么关系？课程提供了腹部接触、肋间区域、乳房外观和术后瘢痕的现场观察。把指标分开，可以保留案例价值，同时避免用颜色或一次压痛变化替代功能判断。

[8.27-24][8.28-16][8.28-17][8.29-03]

症状层

“胀”可能指胀感、可见腹围变化或反复嗳气；“胃痛”先具体为上腹哪里、何时不适。

外观层

颜色、大小、温度感受灯光、角度、接触与身体阶段影响；描述变化前先固定条件。

病史与功能层

食物反应、既往检查、手术及用药各有时间线。感受变化不能独立证明器官恢复或病变消失。

主题	整合后的记录方法	课程提示与局限
腹胀与嗳气	分开胀感、嗳气、排气、排便；写明持续时间和进食关联	8.27腹部个案约10分降到5–6分，但姿势、支持和操作多次改变。[8.27-24][8.27-25]
冷饮或食物后不适	记录具体食物、温度、量、出现时间及其他因素	不能因别人耐受就否认本人，也不通过强行刺激验证理论。[8.28-14][8.28-15]
肋缘/肋间触碰	位置、施力者、诱发反应与即时变化分项记	现场有痛、凉、恶心，也有减轻和变胀；这些不能互相覆盖。[8.28-16][8.28-19][8.28-21]
乳房与乳晕	将颜色、大小、舒适度分别记录，控制灯光和角度	外观不能推断性经历、品行或内脏供血；本人意愿优先。[8.28-17][8.28-18]
旧瘢痕与术后不适	手术背景→症状出现→当前触感/动作→后续变化	红白颜色不能独立判断炎症；先后关系不等于因果。[8.29-03][8.29-22]
食欲、产品与持续性	记录实际进食、同步使用的产品及随访	食欲增加自述、复购和产品说明不能充当普遍疗效数据。[8.28-18][8.28-21]

具体描述 → **核对病史** → **固定比较条件** → **分层解释**

位置、感觉、诱因与时间 | 检查、手术和用药 | 姿势、接触与环境 | 体验、外观、功能分别看

把这些内容连起来

整理补充：若一个案例在不同姿势下反复评分，应画“条件与反馈表”，而非仅画一条不断下降的曲线。前者忠实保留信息，后者可能让读者误以为所有数字来自同一标准测试。腹部和乳房观察也不能直接验证讲者关于肋间神经、迷走神经与全部内脏功能的模型。[8.28-17]

复习与应用

当看到“颜色浅了”“不那么胀了”“压着不痛了”时，先明确它属于哪一层指标，再问还需要什么资料才能回答真正的健康问题。

盆底与排尿：三个问题，一条协调链

8.28末尾开始的排尿主题，在8.29继续演示并系统复盘。主线可以整理为“储存→感知充盈→选择时机→协调排出”。尿意、控尿和排空是相关而不同的结果；一个环节的主观变化，不能替代其他环节的测量。[8.28-22][8.28-23][8.28-24][8.29-13]

尿意

此刻想不想排尿、感觉多强。与饮水、上次排尿和环境有关，不等于实际尿量。

控尿

是否发生不自主漏出，发生在咳嗽/跳跃还是强烈急迫感时。需要具体次数和情境。

排空

能否顺利启动、尿流如何、是否排尽。主观不尽感与实际残余尿是不同信息。

表现	重点记录	课堂结果应怎样理解
咳嗽或跳跃漏尿	活动情境、是否真的漏出、影响程度	这是任务相关表现，不能用操作后尿意下降替代。[8.29-02]
尿急/尿频	急迫程度、频次、间隔、是否伴漏出	8.28有约8–9分降到2–3分的口述，仅说明当时尿意变化。[8.28-23]
尿不尽/排尿困难	启动、尿流、排尿后感觉及相关检查	不能当场排尿时，排空结果应记“尚未测到”。[8.29-02]
术后尿意减弱	手术类型/时间、充盈感、排尿习惯、检查	不能仅从旧疤或触感推定病因。[8.29-07]
下坠或肛周不适	坠胀、痒、痛、组织检查与病史分别写	感觉收紧不能证明痔疮、脱垂等结构问题消失。[8.29-03][8.29-12]
训练与处理选择	明确类型、目标、耐受与后续指标	整体看待感觉和协调，并不否定盆底肌训练的价值。[8.29-01][8.29-13][E03]

储存 膀胱充盈与控尿 → **感知** 记录尿意和情境 → **协调** 选择时机并排出 → **复盘** 尿意、漏尿、排空各自评价

把这些内容连起来

整理补充：这条协调链是功能示意，不是从体表按到某个脊髓节段的路线图。皮肤、椎骨、神经根和脊髓节段不可混为一谈。现有课堂没有连续漏尿次数、残余尿或长期对照资料，因而不能把“一次不想尿了”写成尿失禁已治愈。[8.28-23][8.29-08] NIDDK的治疗说明强调按类型与原因选择方案。[E03]

复习与应用

一份排尿观察表可设：时间、饮水、尿意强度、是否排尿、是否漏出、触发情境、不尽感。它帮助描述问题；具体检测及处理仍按需要进行。

性健康与身体接纳：以本人体验为中心

课程以兴奋、持续、高潮、消退四阶段组织性健康内容，并连接触觉、局部感觉和身体状态。阶段图有助于表达困扰，但不是人人必须完成的固定顺序或时长。健康判断应围绕本人是否困扰、是否疼痛、是否自愿，以及身体和关系背景。[8.29-04][8.29-06][E05]

意愿与需求

欲望和频率可以不同。尊重拒绝、允许改变决定；关系中的强迫不能被解释成被迫者体能或神经有问题。

舒适与功能

疼痛、干涩、胀感和触觉分别描述；某种偏好、较长准备时间或不愿触碰不自动意味着疾病。

接纳与支持

身体观察和镜像可以作为课程体验来理解，须尊重本人选择。外观不满意不能被写成疾病的责任。

观察维度	有帮助的问题	需要避免的简化
欲望与兴奋	在什么情境下愿意或不愿意？是否因此困扰？	不以固定分钟数或频率判断神经损伤。[8.29-04][8.29-06]
润滑、疼痛与舒适	痛在哪里、何时出现，是否与手术、阶段或药物有关？	不能把干涩与疼痛统一归因于心肺弱。[8.29-11][8.29-12]
高潮与恢复	本人如何描述，有无满意或不适，期待是什么？	不用最大心率、统一时长或某一种表现打分。[8.29-04][8.29-10]
局部触觉	痛、痒、坠胀、舒适和无明显感觉分开	没有愉悦不等于某条神经损坏；不同人的结果不混算。[8.29-05][8.29-09]
关系与同意	双方的愿望、拒绝与安全是否受到尊重？	次数不同不决定谁有病，也不产生配合义务。[8.29-07]
术后与身体形象	手术背景、动作、感觉、本人愿意面对什么？	不强迫观看或触摸，不把自我接纳写成治疗疾病的必要条件。[8.29-22][8.29-23]

说明本人困扰 → **定位发生环节** → **理解背景** → **选择支持**

不预设正常答案 | 欲望、舒适、疼痛等 | 身体、药物、关系与经历 | 尊重意愿，按问题评估

把这些内容连起来

外部核对：ACOG将欲望、唤起、高潮、性疼痛及药物相关问题分别讨论，也指出这些问题可能重叠。欲望可能在互动开始后出现，身体、情绪、关系和生活状态均可参与。[E05] 课堂的神经名称和脑影像可作为查证索引，但原图、论文与节段有缺失，不能直接推出外部手法的疗效。[8.29-05][8.29-10]

复习与应用

复习时用中性语言重述一个困扰，说明本人希望怎样改变；再区分哪些是体验、哪些是讲者推测、哪些仍需其他资料。

跨文件案例：看见连续过程与不同结局

案例的完整性来自清楚的过程与限制，而非只保留最后一句“好了”。下面将三天中的关键案例重新串联，保留改善、未改善、条件变化及随访缺口；个案均作匿名主题索引，不保留身份或可识别的私人细节。

不跨人拼接

相邻段落可能换了参与者。某人睡得好，不能补作另一位情绪个案的随访。

不跨指标替代

身体清晰度、自信、疼痛和对某事件的情绪，是不同分数。

不跨时间承诺

现场舒服、次日自述、稳定长期效果属于不同证据层级。

连续案例	过程与实际反馈	最值得学到什么
多症状个案	紧张、腹胀与肩部不适分别记录；初段腹胀减轻而肩部未明确改变，后段再有改善自述。[8.27-17][8.27-18]	分项复测比一个总体“有效”更清楚。
尾骨痛与原有神经痛	练习后曾加重；调整支持后部分尾骨反馈减轻，当天收尾仍有不适。[8.27-18][8.27-19][8.27-25][8.27-26]	原有胸背神经痛没有明确改善证据，不能由尾骨反馈代替。
持续腹部不适	从时间线、用药与胀感入手；多种姿势/支持后评分下降。[8.27-24][8.27-25]	条件改变需要随分数保留，不画伪精确疗效曲线。
情绪与身体案例	清晰度约2→6，自信约4–5→7；部分身体不适减轻，对事件的情绪仍复杂。[8.28-06][8.28-07]	身体变舒服不等于创伤或关系问题已解决。
消化练习反馈	有即时减轻，也出现更胀、更硬和反复操作后的不适。[8.28-16][8.28-19][8.28-21]	负面结果进入同一张表，不能都归为操作不到位。
长期步态困扰	先核对诊断来源，再比较主动/被动，加入分级动作、镜像与注意反馈。[8.29-17][8.29-18][8.29-19]	多种方法同时出现，且缺后续功能评价，不能确定单独疗效。
头眼与节拍练习	有腰部轻松、踏实感，也有残余不适、眼酸、手抖与烦躁。[8.29-16][8.29-21]	完成程度和耐受均重要，不能把疲劳直接解释为脑区被修复。

从主诉出发 → **串联各文件** → **并列所有结果** → **写明结论上限**

分清谁与什么问题 | 保留每阶段条件 | 改善、未改、加重 | 持续性与机制未知

把这些内容连起来

整理补充：案例表可以向两边展开。向前补病史、目标和基线，向后补生活功能、持续性及后续求助。当前资料主要停留在现场，因此完整记录的表现是明确留出缺口，而不是用课堂预测填满缺口。

复习与应用

试着为一例写出“本次观察支持什么”和“本次观察尚不能支持什么”。两句话都应能回到具体文件。

把课程串成可复习、可讨论的知识体系

学习的落点是能解释一个问题、说清一份观察，并知道哪些内容还需要查证。把运动、身体感受和具体健康主题连接起来时，保留各自的指标和适用条件，避免形成“所有问题都归于同一神经机制”的总公式。[8.27-01][8.29-12][8.29-13]

概念复习

用一句话定义术语，再给一个案例；遇到定义不清或原图缺失，回到出处而不补造。

案例复盘

按“问题—条件—反馈—缺口”整理；将不适和未改善与改善放在一起。

应用讨论

先明确目标，再谈任务和负荷；区分课程学习、一般活动与需要专门评估的问题。

综合主题	可以保留的理解	需要校正或继续查证
运动安排	类型、强度、时长、频率和恢复要具体。[8.27-05][8.27-06]	一般指南与4×4等高强度框架分开；不要求人人冲击最大心率。[8.29-20][E02][E09]
平衡与心率	支撑面、姿势、视线和任务难度都影响负荷。[8.29-14]	穿戴读数与真实不适分别核查，不直接诊断前庭病变。
饮食限制	询问具体食物、症状和时间关联。[8.27-14]	不从失衡方向、皮肤或性格要求普遍戒食；食物IgG不能诊断过敏。[E07]
补充剂与抗衰	保留为待查话题，不组成统一保健清单。[8.29-11][8.29-19]	不能从个人经历、价格或简单机制解释推导普遍效果。
产品与手法	记录成分/参数是否明确、过程和反馈。[8.28-21][8.29-07]	原文缺少独立比较资料，不能以用量不足解释全部失败。
身体接纳与差异	尊重本人体验、正常外观差异及拒绝接触的权利。[8.28-18][8.29-23]	不把疾病、亲密偏好或情绪困扰归责于“不爱自己”。
片段与转写	课间、短答、指代不清的内容保留索引。[8.27-07][8.27-23][8.28-20]	没有完整信息时不扩写新理论，也不编造时间戳。

选一个问题 清楚表达学习目标 → **找对应概念** 用表格说明差别 → **连读一个案例** 保留过程与条件 → **形成复盘记录** 写出来源和待解问题

把这些内容连起来

自测清单：①区分触觉、本体感觉、内感知与身体意象；②区分睡眠困难的不同模式；③说明月经记录为何要带时间线；④区分尿意、漏尿与排空；⑤解释感受改善为何不等于组织修复；⑥说清同意与个人意愿在课堂观察中的位置。

复习与应用

最后形成一页个人学习图：中心写当前问题，四周依次放概念、案例、可观察指标和待查证问题。每一项附文件编号，下一次复习便能从问题回到具体材料。

课程出处索引

编号对应日期与文件；独立PDF第1页为原有笔记。合订本页码指PDF物理页序，原文仍保留在原资料夹。

[8.27-01] 课程导入与学习路径

独立PDF：01_课程导入与学习路径_笔记与原文.pdf
8.27/1.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第3页

[8.27-02] 女性生命阶段与身体感受

独立PDF：02_女性生命阶段与身体感受_笔记与原文.pdf
8.27/2.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第7页

[8.27-03] 身体知觉与神经科学框架

独立PDF：03_身体知觉与神经科学框架_笔记与原文.pdf
8.27/3.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第11页

[8.27-04] 自主神经与症状表达

独立PDF：04_自主神经与症状表达_笔记与原文.pdf
8.27/4.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第15页

[8.27-05] 血糖指标与运动安排

独立PDF：05_血糖指标与运动安排_笔记与原文.pdf
8.27/5.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第19页

[8.27-06] 运动剂量与身体调节

独立PDF：06_运动剂量与身体调节_笔记与原文.pdf
8.27/6.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第23页

[8.27-07] 课间交流片段

独立PDF：07_课间交流片段_笔记与原文.pdf
8.27/7.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第27页

[8.27-08] 学习负荷与自主神经

独立PDF：08_学习负荷与自主神经_笔记与原文.pdf
8.27/8.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第29页

[8.27-09] 安全感、进食与触觉反馈

独立PDF：09_安全感、进食与触觉反馈_笔记与原文.pdf
8.27/9.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第33页

[8.27-10] 身体位置感与镜像观察

独立PDF：10_身体位置感与镜像观察_笔记与原文.pdf
8.27/10.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第37页

[8.27-11] 闭眼身体感受的课堂记录

独立PDF：11_闭眼身体感受的课堂记录_笔记与原文.pdf
8.27/11.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第41页

[8.27-12] 身体感受反馈与个案筛选

独立PDF：12_身体感受反馈与个案筛选_笔记与原文.pdf
8.27/12.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第45页

课程出处索引（续）

编号对应日期与文件；独立PDF第1页为原有笔记。合订本页码指PDF物理页序，原文仍保留在原资料夹。

[8.27-13] 前庭相关演示与复测

独立PDF：13_前庭相关演示与复测_笔记与原文.pdf

8.27/13.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第48页

[8.27-14] 前庭训练问答与饮食争议

独立PDF：14_前庭训练问答与饮食争议_笔记与原文.pdf

8.27/14.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第52页

[8.27-15] 练习反馈与难度调整

独立PDF：15_练习反馈与难度调整_笔记与原文.pdf

8.27/15.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第56页

[8.27-16] 平衡反应与发育反射导入

独立PDF：16_平衡反应与发育反射导入_笔记与原文.pdf

8.27/16.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第59页

[8.27-17] 多症状个案与初步复测

独立PDF：17_多症状个案与初步复测_笔记与原文.pdf

8.27/17.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第63页

[8.27-18] 开合动作示范与新个案

独立PDF：18_开合动作示范与新个案_笔记与原文.pdf

8.27/18.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第67页

[8.27-19] 尾骨痛个案的连续观察

独立PDF：19_尾骨痛个案的连续观察_笔记与原文.pdf

8.27/19.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第71页

[8.27-20] 三类演示的课堂复盘

独立PDF：20_三类演示的课堂复盘_笔记与原文.pdf

8.27/20.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第75页

[8.27-21] 复测原则与辅助边界

独立PDF：21_复测原则与辅助边界_笔记与原文.pdf

8.27/21.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第78页

[8.27-22] 成人与儿童训练的区别

独立PDF：22_成人与儿童训练的区别_笔记与原文.pdf

8.27/22.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第82页

[8.27-23] 下颌功能问答片段

独立PDF：23_下颌功能问答片段_笔记与原文.pdf

8.27/23.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第84页

[8.27-24] 感觉分类与腹胀个案导入

独立PDF：24_感觉分类与腹胀个案导入_笔记与原文.pdf

8.27/24.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第86页

课程出处索引（续）

编号对应日期与文件；独立PDF第1页为原有笔记。合订本页码指PDF物理页序，原文仍保留在原资料夹。

[8.27-25] 腹部不适与枕下手法案例

独立PDF：25_腹部不适与枕下手法案例_笔记与原文.pdf
8.27/25.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第90页

[8.27-26] 个案复测与当天收尾

独立PDF：26_个案复测与当天收尾_笔记与原文.pdf
8.27/26.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第94页

[8.28-01] 内分泌系统与月经调节

独立PDF：01_内分泌系统与月经调节_笔记与原文.pdf
8.28/1(1).doc | 笔记第1页 | 当日合订本第4页

[8.28-02] 月经记录、压力与甲状腺

独立PDF：02_月经记录、压力与甲状腺_笔记与原文.pdf
8.28/2(1).doc | 笔记第1页 | 当日合订本第8页

[8.28-03] 检查结果与课堂应用边界

独立PDF：03_检查结果与课堂应用边界_笔记与原文.pdf
8.28/3(1).doc | 笔记第1页 | 当日合订本第12页

[8.28-04] 压力反馈与身心调节问答

独立PDF：04_压力反馈与身心调节问答_笔记与原文.pdf
8.28/4(1).doc | 笔记第1页 | 当日合订本第16页

[8.28-05] 感觉输入、疼痛与闸门理论

独立PDF：05_感觉输入、疼痛与闸门理论_笔记与原文.pdf
8.28/5(1).doc | 笔记第1页 | 当日合订本第20页

[8.28-06] 情绪与身体个案的基线记录

独立PDF：06_情绪与身体个案的基线记录_笔记与原文.pdf
8.28/6(1).doc | 笔记第1页 | 当日合订本第24页

[8.28-07] 枕下案例的反馈与练习问题

独立PDF：07_枕下案例的反馈与练习问题_笔记与原文.pdf
8.28/7(1).doc | 笔记第1页 | 当日合订本第28页

[8.28-08] 分组练习反馈与概念衔接

独立PDF：08_分组练习反馈与概念衔接_笔记与原文.pdf
8.28/8(1).doc | 笔记第1页 | 当日合订本第32页

[8.28-09] 本体感觉与睡眠觉醒基础

独立PDF：09_本体感觉与睡眠觉醒基础_笔记与原文.pdf
8.28/9(1).doc | 笔记第1页 | 当日合订本第35页

[8.28-10] 睡眠主诉与情绪个案访谈

独立PDF：10_睡眠主诉与情绪个案访谈_笔记与原文.pdf
8.28/10(1).doc | 笔记第1页 | 当日合订本第39页

课程出处索引（续）

编号对应日期与文件；独立PDF第1页为原有笔记。合订本页码指PDF物理页序，原文仍保留在原资料夹。

[8.28-11] 压力模型与个体资源

独立PDF：11_压力模型与个体资源_笔记与原文.pdf

8.28/11(1).doc | 笔记第1页 | 当日合订本第43页

[8.28-12] 颈部感觉、咳嗽与声音反馈

独立PDF：12_颈部感觉、咳嗽与声音反馈_笔记与原文.pdf

8.28/12(1).doc | 笔记第1页 | 当日合订本第47页

[8.28-13] 颈部练习的边界与异常反馈

独立PDF：13_颈部练习的边界与异常反馈_笔记与原文.pdf

8.28/13(1).doc | 笔记第1页 | 当日合订本第51页

[8.28-14] 从颈部练习转向消化问题

独立PDF：14_从颈部练习转向消化问题_笔记与原文.pdf

8.28/14(1).doc | 笔记第1页 | 当日合订本第55页

[8.28-15] 上腹不适的问诊与位置描述

独立PDF：15_上腹不适的问诊与位置描述_笔记与原文.pdf

8.28/15(1).doc | 笔记第1页 | 当日合订本第58页

[8.28-16] 腹部触碰示范与胸壁感觉

独立PDF：16_腹部触碰示范与胸壁感觉_笔记与原文.pdf

8.28/16(1).doc | 笔记第1页 | 当日合订本第62页

[8.28-17] 内脏感觉模型与乳房观察

独立PDF：17_内脏感觉模型与乳房观察_笔记与原文.pdf

8.28/17(1).doc | 笔记第1页 | 当日合订本第66页

[8.28-18] 乳晕变化、哺乳与比较方法

独立PDF：18_乳晕变化、哺乳与比较方法_笔记与原文.pdf

8.28/18(1).doc | 笔记第1页 | 当日合订本第70页

[8.28-19] 肋间练习片段与复测提醒

独立PDF：19_肋间练习片段与复测提醒_笔记与原文.pdf

8.28/19(1).doc | 笔记第1页 | 当日合订本第74页

[8.28-20] 分组交流与上课前过渡

独立PDF：20_分组交流与上课前过渡_笔记与原文.pdf

8.28/20(1).doc | 笔记第1页 | 当日合订本第76页

[8.28-21] 反应差异与效果持续性

独立PDF：21_反应差异与效果持续性_笔记与原文.pdf

8.28/21(1).doc | 笔记第1页 | 当日合订本第79页

[8.28-22] 储尿与排尿的基础框架

独立PDF：22_储尿与排尿的基础框架_笔记与原文.pdf

8.28/22(1).doc | 笔记第1页 | 当日合订本第83页

课程出处索引（续）

编号对应日期与文件；独立PDF第1页为原有笔记。合订本页码指PDF物理页序，原文仍保留在原资料夹。

[8.28-23] 尿意即时变化与解剖说明

独立PDF：23_尿意即时变化与解剖说明_笔记与原文.pdf

8.28/23(1).doc | 笔记第1页 | 当日合订本第87页

[8.28-24] 排尿主题复盘与课程收尾

独立PDF：24_排尿主题复盘与课程收尾_笔记与原文.pdf

8.28/24(1).doc | 笔记第1页 | 当日合订本第91页

[8.29-01] 课前反馈与排尿主题导入

独立PDF：01_课前反馈与排尿主题导入_笔记与原文.pdf

8.29/1.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第3页

[8.29-02] 排尿症状与骶部演示

独立PDF：02_排尿症状与骶部演示_笔记与原文.pdf

8.29/2.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第6页

[8.29-03] 瘢痕与肛周不适个案

独立PDF：03_瘢痕与肛周不适个案_笔记与原文.pdf

8.29/3.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第10页

[8.29-04] 性反应周期与个体差异

独立PDF：04_性反应周期与个体差异_笔记与原文.pdf

8.29/4.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第14页

[8.29-05] 盆底感觉与神经术语梳理

独立PDF：05_盆底感觉与神经术语梳理_笔记与原文.pdf

8.29/5.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第18页

[8.29-06] 课间反馈与性健康问答

独立PDF：06_课间反馈与性健康问答_笔记与原文.pdf

8.29/6.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第21页

[8.29-07] 关系需求与术后尿意问答

独立PDF：07_关系需求与术后尿意问答_笔记与原文.pdf

8.29/7.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第24页

[8.29-08] 腰腹区域演示与定位疑点

独立PDF：08_腰腹区域演示与定位疑点_笔记与原文.pdf

8.29/8.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第28页

[8.29-09] 分组练习与会阴感觉复盘

独立PDF：09_分组练习与会阴感觉复盘_笔记与原文.pdf

8.29/9.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第32页

[8.29-10] 感觉影像与性功能课堂总结

独立PDF：10_感觉影像与性功能课堂总结_笔记与原文.pdf

8.29/10.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第36页

课程出处索引（续）

编号对应日期与文件；独立PDF第1页为原有笔记。合订本页码指PDF物理页序，原文仍保留在原资料夹。

[8.29-11] 疼痛问答与训练适配

独立PDF：11_疼痛问答与训练适配_笔记与原文.pdf

8.29/11.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第40页

[8.29-12] 课程设计与盆底问题收束

独立PDF：12_课程设计与盆底问题收束_笔记与原文.pdf

8.29/12.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第44页

[8.29-13] 泌尿系统的整体复盘

独立PDF：13_泌尿系统的整体复盘_笔记与原文.pdf

8.29/13.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第48页

[8.29-14] 运动心率与平衡负荷

独立PDF：14_运动心率与平衡负荷_笔记与原文.pdf

8.29/14.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第52页

[8.29-15] 身体重心感知与背部紧张

独立PDF：15_身体重心感知与背部紧张_笔记与原文.pdf

8.29/15.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第56页

[8.29-16] 头眼配合演示的反馈与细节

独立PDF：16_头眼配合演示的反馈与细节_笔记与原文.pdf

8.29/16.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第60页

[8.29-17] 长期步态困扰个案的开始

独立PDF：17_长期步态困扰个案的开始_笔记与原文.pdf

8.29/17.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第64页

[8.29-18] 分级动作与身体感受练习

独立PDF：18_分级动作与身体感受练习_笔记与原文.pdf

8.29/18.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第68页

[8.29-19] 个案收尾与抗衰话题

独立PDF：19_个案收尾与抗衰话题_笔记与原文.pdf

8.29/19.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第71页

[8.29-20] 运动建议与感觉敏感话题

独立PDF：20_运动建议与感觉敏感话题_笔记与原文.pdf

8.29/20.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第75页

[8.29-21] 手指节拍练习与不同反馈

独立PDF：21_手指节拍练习与不同反馈_笔记与原文.pdf

8.29/21.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第79页

[8.29-22] 关节弹响与术后身体感受

独立PDF：22_关节弹响与术后身体感受_笔记与原文.pdf

8.29/22.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第82页

课程出处索引（续）

编号对应日期与文件；独立PDF第1页为原有笔记。合订本页码指PDF物理页序，原文仍保留在原资料夹。

[8.29-23] 身体接纳与课程收尾问答

独立PDF：23_身体接纳与课程收尾问答_笔记与原文.pdf

8.29/23.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第86页

外部核对与阅读说明

[E01] IASP｜疼痛定义与术语

疼痛是个人体验，不能仅从组织或神经信号推断。

https://www.iasp-pain.org/resources/terminology/

[E02] WHO｜身体活动与久坐指南

一般成人有氧及肌力活动建议；不等于个体运动处方。

https://www.who.int/europe/publications/i/item/9789240014886

[E03] NIDDK｜尿失禁的治疗

按类型及原因选择处理，盆底肌训练是治疗选项之一。

https://www.niddk.nih.gov/health-information/urologic-diseases/bladder-control-problems/treatment

[E04] NIDCD｜平衡障碍

平衡涉及多个系统，评估和康复应个体化。

https://www.nidcd.nih.gov/health/balance-disorders

[E05] ACOG｜女性性健康

欲望、唤起、高潮及疼痛问题可相互重叠，并受多种因素影响。

https://www.acog.org/womens-health/faqs/your-sexual-health

[E06] NHS｜月经

周期存在个体差异，变化需联系本人模式和相关症状。

https://www.nhs.uk/conditions/periods/

[E07] AAAAI｜食物IgG检测

食物IgG不能据以诊断食物过敏或不耐受。

https://www.aaaai.org/tools-for-the-public/conditions-library/allergies/igg-food-test

[E09] NTNU CERG｜运动建议与4×4间歇

相关4×4框架采用85%至95%最大心率，不要求达到100%。

https://www.ntnu.edu/cerg/advice

整理口径

课程模型用于准确呈现讲者的思路；课堂观察只说明现场发生的变化；整理补充用于解释联系与阅读方法；外部核对以E编号标注。图中的箭头表示概念关系或复盘顺序，不自动代表已经证实的生理因果。依赖现场图像的手法不从残缺转写补成操作教程。

引用说明：以客户提供的课程标题与日期归档。课堂来源指向已生成的结构化笔记；外部核对仅用于对应基础知识与关键边界，不表示相关机构认可课堂技术。没有可统一核验的录音时间戳，因此不编造分钟定位。

版本：2026-10-30。8.15的11号文件已补齐；全部118份材料均完成通读与主题映射。原始资料未改动，公开版不附原文、个人身份或私人经历细节。